

Auszug aus den medizinischen Daten

vom 17.11.25 bis 13.03.26

von:

Tim Heller
Facharzt für Urologie
Bahnhofstr. 47
87435 Kempten
Tel.: 0831/18008
Fax.: 0831/18266

über:

Stadelmann, Thomas
geb.: 06.04.94
Pat.Nr.: 24339

*** Ausgewählte Einträge ***

17.11.25 G Auf Infoblätter über Datenschutz heute hingewiesen, zur Ansicht
G ausgehändigt, durch die Helferin Frau Wählte.
G Ihm/Ihr wurde angeboten, eine Kopie hiervon mitzunehmen, dies
G wurde jedoch nicht erwünscht.
% Datenzugriff zugestimmt: 17.11.2025, 8:02 (Praxis Heller)
/ BT:024339 Datenzugriff
% Patientenbild abgelehnt: 17.11.2025, 8:02 (Praxis Heller)
A m
K FA-Kinderwunschzentrum/M/K/:Kryokonservierung vor möglicher
K Orchiektomie links
D Genitalmykose
* Phimose
D Verdacht auf Hodentumor links
S
L 410HL-420HR-420NHR-420NHL \$3,4/3-1 \$3,4/1
L 5-1754
L 75-09br
J .
J 16.11.2025: Erstmalige Vorstellung des Patienten bei
J progredienter Phimose seit etwa 10 Jahren.. Seit September
J diesen Jahres deutlicher Progress mit Rissbildung und
J Unfähigkeit zur Retraktion. Laut Patient Östrogensalbe vom
J Hausarzt ohne merkliche Veränderung. Der Patient arbeitet
J wöchentlich 60-70 Stunden als Softwareprogrammierer
J selbstständig und fährt täglich ca. 2 Stunden Fahrrad und lauf
J Ultramarathon. Zusätzlich berichtet der Patient seit 5-6 Wochen
J über juckende Flecken vom Po bis zum Skrotum. Eine Pilzsalbe
J seit Donnerstag letzter Woche habe keine Veränderung ergeben.
J Ähnliche Hodenkrebskontrolle beim Hausarzt. Hodentrauma nicht
J erinnerlich.
S .
S Hoden rechts homogen mit schmalen Nebenhoden, Hoden links mit ca.
S 1,3 cm messender Verkalkung und suspekten Veränderungen.
S Seitengleiche Perfusion.
S .
B Deutliche narbige Phimose, Retraktion nicht möglich, rechter
B Hoden asuspekt mit schmalen Nebenhoden, linker Hoden mit
B deutlicher Verhärtung im oberen Anteil ca. 1½ cm, nicht
B druckdolent, schmalen Nebenhoden. V. a. Pilzinfektion bei
B typischen zirkulären Hautveränderungen von der rechten Leiste
B bis zum Analbereich
N .
N Procedere: Zunächst MRT Hoden Abdomen sowie Röntgen-Thorax dann
N zusätzlich Vorstellung zur Kryokonservierung, im Anschluss
N Vorstellung im Klinikum zur möglichen Exzision. Phimosen
N Therapie sekundär und im Verlauf zu planen.
J .

H pH:5 Ew:- Glc:- Nit:- Hb:- Leu/Stix:-
 H Spez.Gew.:1010 Leu.:1, Ery.:1, Kokk.:(+) Stäb:
 H Sonst: Spontanurin/Mittelstrahlurin
 L 3510(Urin)-3511(Urin)-3504(Urin)-3505(Urin)
 E Kulturansatz auf Böden Cled,MacConk.,Entero,Pilzbod.
 E KZ 10/0, Hemmtest: neg.
 L 4531x3(u=Urin:Bak)-4607(u=Urin:Hemmst.)-4715(u=Urin:Pilznährb)
 M Decoderm Tri,CRE 25 g N1|bei Bedarf
 K FA-Radiologie/M/K/:Röntgen Thorax erbeten, fraglich staging?
 K Unklare Raumforderung Hoden links
 K FA-Radiologie/M/K/:MRT Hoden/Abdomen erbeten, fraglich staging?
 K Laborauftrag/K/
 P Termin Do.: 20.11. um 13.15 Uhr, Radiologie KF für MRT Hoden/
 P Abdomen und Rö-Thorax.
 K Mini Vidas: Blutabnahme Testosteron
 Y Testo 1 = 4,81 Testo 2 = 4,78
 Y Mittelwert Testo = 4,80 (Norm 2,27 - 10,30 ng/ml) (8.25 Uhr)
 L 4042-250
 K Blutabnahme, Laborgemeinschaft/Gärtner: Krea, kl.BB,
 L 3585H1
 L 3550(nach Blutabnahme)
 K Blutabnahme, Schottdorf: Beta-HCG, AFP, LDH
 Y 20|END - 68470120 0120
 Y Auftragseingang: 17.11.2025
 Y Befunderstellung: 17.11.2025 12:16
 Y KREA J2 = 0.98 mg/dl Norm. 0.67 - 1.13
 Y GFR = 89.5 ml/min Norm. > 60
 Y Berechnung bezogen auf Standard-Körperoberfläche (1,73 qm)
 Y GFR60 = ohne Wert
 Y Eine GFR > 60 ml/min pro 1,73 qm sollte nicht als exakter
 Y Wert, sondern lediglich als "> 60" interpretiert werden, da
 Y die MDRD-Formel für diesen Bereich nicht ausreichend
 Y validiert ist. Eine exakte Messung ist mit Kreatinin
 Y enzymatisch und der CKD-EPI-Formel möglich.
 Y IHLH = 5 INDEX; KBB = ohne Wert
 Y LEUKO3 = 5.12 Tsd./µl Norm. 3.9 - 9.8
 Y ERYTH3 = 4.82 Mio/µl Norm. 4.54 - 5.77
 Y HAEMO = 15.4 g/dl Norm. 13.5 - 17.5
 Y HAEMA3 = 43.3 % Norm. 40 - 51
 Y MCVMC3 = 89.8 fl Norm. 80 - 96; MCHMC3 = 32.0 pg Norm. 28 - 33
 Y MCHCH3 = 35.6 g/dl Norm. 33 - 37
 Y THROM3 = 240 Tsd./µl Norm. 146 - 328
 Y ERYVB3 = 11.6 % L Norm. 12 - 15
 / Anhang: Laborbefund
 Y Beta-HCG = <0,2 (Norm bis 2,0 IU/l)
 Y LDH = 210 (Norm bis 250 U/l)
 Y AFP = 3,2 (Norm bis 7 ng/ml)
 20.11.25 > MV:7323-01-01, msc, Befundbericht, Röntgen Thorax 20.11.25
 > MV:7324-01-01, msc, Befundbericht, Szinti 20.11.25
 Q Röntgen-Thorax in 2 Ebenen vom 20.11.2025: Unauffälliger Herz-
 Q Lungen-Befund. Keine suspekten Knochenläsionen.
 Q
 Q Kernspintomografie des Beckens vom 20.11.2025: Ausgeprägte
 Q Hodenatrophie links. Hydrozele testis bds. Keine pathologisch
 Q vergrößerten Lymphknoten. Kein malignitätssuspekter oder akut
 Q entzündlicher Herdbefund.
 L 1 \$ 3,4/1
 L 0a
 J Mitteilung der aktuellen Befunde durch Hr. Heller/Dr. Appel
 28.11.25 L 09kox2
 > MV:7537-01-01, msc, Befundbericht, Ferti Beratung 17.11.25
 Y Arztbrief Kinderwunsch Zentrum Kempten 17.11.2025:
 Y Fertilitätsprotektive Beratung vom 17.11.2025. Bestimmung von
 Y serologischer Parameter sowie die erste Abgabe zur

16.12.25 Y Kryokonservierung.
 A cd
 P 410HL-420HR-420NHR-420NHL \$3,4/3-
 L 1(Phimose; Planung OP) \$3,4/1
 L 5(Phimose; Planung OP)
 P 1754
 P 75-09br
 J .
 Q Kernspintomografie des Beckens vom 20.11.2025: Ausgeprägte
 Q Hodenatrophie links. Hydrozele testis bds. Keine pathologisch
 Q vergrößerten Lymphknoten. Kein malignitätssuspekter oder akut
 Q entzündlicher Herdbefund.
 J .
 J 12/25: Wiedervorstellung zur Planung einer operativen Versorgung
 J bei symptomatischer ausgeprägter Phimose. Der Patient wird über
 J Risiken und Nebenwirkung aufgeklärt und wird ein OP-Termin
 J vereinbart.
 J 16.11.2025: Erstmalige Vorstellung des Patienten bei
 J progredienter Phimose seit etwa 10 Jahren.. Seit September
 J diesen Jahres deutlicher Progress mit Rissbildung und
 J Unfähigkeit zur Retraktion. Laut Patient Östrogensalbe vom
 J Hausarzt ohne merkliche Veränderung. Der Patient arbeitet
 J wöchentlich 60-70 Stunden als Softwareprogrammierer
 J selbstständig und fährt täglich ca. 2 Stunden Fahrrad und lauf
 J Ultramarathon. Zusätzlich berichtet der Patient seit 5-6 Wochen
 J über juckende Flecken vom Po bis zum Skrotum. Eine Pilzsalbe
 J seit Donnerstag letzter Woche habe keine Veränderung ergeben.
 J Ähnliche Hodenkrebskontrolle beim Hausarzt. Hodentrauma nicht
 J Erinnerung.
 S .
 S .
 B Deutliche narbige Phimose, Retraktion nicht möglich
 N .
 N Procedere: Planung ambulanter Zirkumzision bei uns
 * Phimose
 H pH:- Ew:- Glc:- Nit:- Hb:- Leu/Stix:-
 H Spez.Gew.:1020 Leu.:1, Ery.:1, Kokk.:(+) Stäb:-
 H Sonst: - Spontanurin/Mittelstrahlurin
 L 3510(Urin)-3511(Urin)-3504(Urin)-3505(Urin)
 E Kulturansatz auf Böden Cled,MacConk.,Entero,Pilzbod.
 E KZ 10/0, Hemmtest: neg.
 L 4531x3(u=Urin:Bak)-4607(u=Urin:Hemmst.)-4715(u=Urin:Pilznährb)
 E Abstrich von der Glans penis auf CLED, McConkey, Pilz,
 E nach 48-72 Std: - Candida-Kolonien, "KZ" 10/0: unspez.
 E bakt. Mischflora (24 Std).
 L 4531x2(Glans)-4715x2(Glans)-298
 P Der Patient gibt seine Einwilligung zur CICI, wenn er zur BA
 P kommt!!!!
 19.01.26 M Decoderm Tri,CRE 25 g N1|bei Bedarf
 G Einverständniserklärung Circumcision vom Patienten unterschrieben
 G Kopie wurde ausgehändigt.
 L 09kox2
 K Laborauftrag/K/
 K Blutabnahme, Laborgemeinschaft/Gärtner: kl.BB, Quick+PTT
 L 250
 L 3550(nach Blutabnahme)
 L 3607-3605
 L 1 \$ 3,4/1
 L 5
 J .
 J 19.1.2026: Gute Wirksamkeit von Decoderm Tri bei perianalem
 J Juckreiz. Aktuell wieder Beschwerdezunahme. Weiterhin Wunsch
 J nach ambulanter Zirkumzision. Diesbezüglich ergeht eine
 J Aufklärung. Der Patient berichtet über keine nennenswerten

J Fragen.
 Y 17|END - 68470961 0961
 Y Auftragseingang: 19.01.2026
 Y Befunderstellung: 19.01.2026 19:55
 Y KBB = ohne Wert; LEUK03 = 7.04 Tsd./ μ l Norm. 3.9 - 9.8
 Y ERYTH3 = 4.89 Mio/ μ l Norm. 4.54 - 5.77
 Y HAEMO = 15.8 g/dl Norm. 13.5 - 17.5
 Y HAEMA3 = 44.1 % Norm. 40 - 51
 Y MCVMC3 = 90.2 fl Norm. 80 - 96; MCHMC3 = 32.3 pg Norm. 28 - 33
 Y MCHCH3 = 35.8 g/dl Norm. 33 - 37
 Y THROM3 = 289 Tsd./ μ l Norm. 146 - 328
 Y ERYVB3 = 11.5 % L Norm. 12 - 15; QUICK1 = 94 % Norm. 70 - 130
 Y INR1 = 1.04 KA
 Y 0.9 - 1.26
 Y Therapeutischer Bereich:
 Y milde Antikoagulanzenientherapie: 2,0 - 3,0
 Y scharfe Antikoagulanzenientherapie: 3,0 - 4,0
 Y hohes Blutungsrisiko: > 5,0
 Y PTT1 = 31 sec Norm. 25.1 - 36.5
 / Anhang: Laborbefund
 20.01.26 L 1 \$ 3,4/1
 11.02.26 O Lokalanästhesie der Peniswurzel zirkulär mit >20 ml Xylocain 1%.
 O Nachspritzen erforderlich.
 O Zunächst Resektion beider Vorhautblätter gemeinsam entlang einer
 O Peanklemme unter Spannung, danach typ. zirkuläre Resektion des inn.
 O Blattes. Blutstillung mittels Umstechung, sodann Readaptation der
 O beiden Blätter durch EKN Plaincat 4x0. Druckverband.
 O Komplikationen: keine
 * Z.n. ambulanter Circumcision am 11.02.26
 J .
 L 3(7.00; ambulante Circumcision)-5(7.00; ambulante Circumcision)
 L 62x3-491x3(Schmerzen, Nachspritzen erforderlich)-442-60
 L 1741 \$3,5/3-204
 L 272x2(M=NaCl)-452(m=Dormicum) \$ 3,5/1-448-09nacx2-09be
 L 5(Circumcision, Übergabe, Entlassgespräch)
 L 1(Übergabe, Entlassgespräch) \$ 3,5/1
 L 090infx2
 L 090op
 L 09serx4
 L 250
 L 1(9.00*) \$ 3,5/1-5(9.00*)
 12.02.26 L 1(Wundkontrolle) \$ 3,4/1
 L 5(Wundkontrolle)
 J .
 J 12.2.2026: Wiedervorstellung nach gestriger ambulanter
 J Zirkumzision. Aktuell keine Schmerzen. Keine Nachblutungen. Kein
 J Hinweis auf Wundinfekt. Erneute Kontrolle für in einer Woche
 J durch Freigabe ab morgen. Tägliche Kamillosan Sitzbäder mit
 J Bepanthenalbenanwendung.
 M Kamillosan Konzentrat, KON 250 ml N2|bei Bedarf
 M Bepanthen Wund U Heilsalbe, SAL 50 g N2|bei Bedarf
 16.02.26 > MV:9334-01-01, msc, Befundbericht, Histo Präputium 16.02.26
 Z Pathologisch-anatomische Begutachtung vom 12.2.2026: Präputium
 Z mit Lichen sclerosus et atrophicus. Kein Malignitätsverdacht.
 20.02.26 A LW
 M Kamillosan Konzentrat, KON 250 ml N2|bei Bedarf
 L 1(Restfädenkontrolle) \$ 3,4/1
 L 5(Restfädenkontrolle)
 J .
 J 20.2.2026: Wiedervorstellung zur erneuten Wundkontrolle. Der
 J Patient gibt aktuell keine Beschwerden an. Initial Schmerzen bei
 J Erektion aktuell keine Beschwerden. Weiterhin 2 x tägliche
 J Kamillosan Sitzbäder.